

QUAND ÇA COINCE

Conflits, signalement, recours — agir sans perdre le lien.

Guide F — Série pratique EHPAD · Culture du soin

Sommaire

1. Comprendre d'où vient le blocage

Conflit, malentendu, négligence, maltraitance — ce ne sont pas les mêmes situations.

2. Les signaux d'alerte à ne pas ignorer

Ce qui doit vous alerter — et ce qui nécessite une action immédiate.

3. La marche à suivre — étape par étape

De la première conversation à la saisine externe — dans l'ordre.

4. Signaler une maltraitance

Quand et comment signaler — sans hésiter, sans accélérer trop vite.

5. Préserver le lien malgré le conflit

Parce que votre proche vit toujours là — et que la relation avec l'équipe le touche directement.

6. Modèles de courriers — à adapter

Des formules prêtes à utiliser pour les situations les plus fréquentes.

Introduction

Il y a des moments où ça ne passe plus. Où la confiance est ébranlée. Où une situation reste sans réponse malgré vos démarches. Où vous observez quelque chose qui vous révolte et ne savez pas quoi faire.

Ce guide est là pour ces moments-là. Pas pour attiser les conflits — pour vous donner les outils d’agir efficacement, dans l’ordre, sans perdre de vue l’essentiel : votre proche vit toujours dans cet établissement. Ce que vous faites — et comment vous le faites — aura un impact direct sur son quotidien.

Ce que j’observe sur le terrain

Les situations qui dérapent le plus sont celles où on a attendu trop longtemps avant d’agir — et où on a finalement agi dans l’explosion. La colère accumulée sort d’un coup, trop fort, sans structure. L’établissement se ferme. La famille est étiquetée “difficile”. Et le résident se retrouve pris en étau.

Agir tôt, méthodiquement, par écrit — c’est la voie qui protège à la fois votre proche et votre crédibilité.

1. Comprendre d'où vient le blocage

Avant d'agir, identifier. Parce que toutes les situations ne se traitent pas de la même façon.

Le malentendu

Vous avez compris quelque chose différemment de ce qui était voulu. Ou une information n'a pas été transmise. C'est de loin la situation la plus fréquente. Elle se règle par une conversation directe et calme avec le bon interlocuteur. Pas besoin d'escalader.

La négligence organisationnelle

Le système est débordé et des choses passent à travers les mailles. Ce n'est pas de la malveillance — c'est une conséquence du manque de moyens. Cela ne l'excuse pas, mais ça change la façon d'aborder le problème : signaler, demander des ajustements, mettre par écrit pour laisser une trace.

Le conflit de valeurs

Vous n'êtes pas d'accord sur une décision médicale, sur la manière d'accompagner votre proche, sur ce qui est prioritaire. C'est plus complexe — cela nécessite une réunion formelle, une écoute mutuelle, parfois l'intervention d'un tiers (médecin, psychologue, médiateur).

La maltraitance

C'est la situation la plus grave. Elle peut être physique, psychologique, financière, ou par négligence grave. Elle nécessite une action rapide, documentée et officielle. Voir chapitre 4.

*Identifier le type de problème, c'est choisir la bonne réponse.
Toutes les situations ne méritent pas la même intensité de
réaction.*

2. Les signaux d'alerte à ne pas ignorer

Certains signaux doivent déclencher une action immédiate. D'autres sont des signes à surveiller et à signaler sans urgence absolue. Voici comment distinguer les deux.

Signaux d'urgence — agissez immédiatement

- Des traces de coups, blessures inexplicables ou qui ne correspondent pas aux explications données.
- Votre proche vous dit qu'il est frappé, humilié, menacé — même si cela semble confus.
- Une dégradation physique rapide sans explication médicale claire.
- Votre proche exprime une peur intense de certaines personnes ou de certains moments.
- Des sommes d'argent disparaissent sans explication.

Signaux à surveiller — signalez et suivez

- Une perte de poids importante et inexpliquée sur plusieurs semaines.
- Votre proche semble toujours dans la même tenue, peu soigné, pas rasé ou mal coiffé.
- Il est toujours seul, jamais stimulé, toujours devant la télévision.
- L'équipe évite vos questions ou donne des réponses vagues et contradictoires.
- Des décisions importantes sont prises sans vous informer.

Votre instinct compte. Si quelque chose ne va pas — notez-le, datez-le, et agissez.

3. La marche à suivre — étape par étape

Chaque étape franchie légitime la suivante. Ne sautez pas d'étapes — sauf en cas d'urgence absolue.

Étape 1 — La conversation directe

Avec la personne directement concernée, si c'est possible et sans danger. Exposez les faits, calmement, et demandez une explication. Beaucoup de situations se règlent là. Si vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante — passez à l'étape suivante.

Étape 2 — La cadre de santé

Demandez un rendez-vous formel. Présentez les faits par écrit (un mail de confirmation de ce que vous avez observé, la date, votre demande). Demandez une réponse écrite ou une action traçable.

Étape 3 — La direction

Si la cadre n'a pas répondu ou si le problème persiste — courrier à la direction, avec copie à la cadre. Résumez les faits, les démarches antérieures, votre demande précise. Mentionnez que vous attendez une réponse écrite sous quinze jours.

Étape 4 — Le médiateur ou la Commission des Usagers

Demandez à rencontrer le médiateur de l'établissement. C'est une instance interne mais indépendante. Elle peut faciliter un dialogue bloqué et forcer une réponse formelle de la direction.

Étape 5 — Les instances externes

Si les voies internes sont épuisées ou si la situation est grave :

- **L'ARS (Agence Régionale de Santé)** — pour les manquements graves aux obligations de soin et de sécurité.
- **Le Conseil Départemental** — pour les questions relevant de la dépendance et du financement.
- **Le Défenseur des droits** — pour les violations des droits fondamentaux.

- **Le Procureur de la République** — en cas de maltraitance avérée ou de délit.

Chaque étape documentée renforce la suivante. Ne brûlez pas les étapes — sauf urgence.

4. Signaler une maltraitance

La maltraitance en EHPAD existe. Elle est plus rare qu'on ne le croit — et plus répandue qu'on ne l'admet. Elle peut être le fait d'un individu, d'une culture d'établissement, ou d'un système à bout de souffle qui ne protège plus.

Les formes de maltraitance

- **Physique** : coups, brusqueries, contentions abusives, soins douloureux effectués sans égard.
- **Psychologique** : humiliations, menaces, moqueries, infantilisation excessive, isolement.
- **Financière** : vol, abus de faiblesse, détournement de l'argent de poche.
- **Par négligence** : abandon de soins, non-réponse aux besoins primaires, laisser quelqu'un dans sa souillure.
- **Institutionnelle** : organisation qui prive systématiquement les résidents de leurs droits ou de leurs besoins.

Comment signaler

- **Notez et datez tout ce que vous observez.** Faits précis, date, heure, personnes présentes. Des photos si possible et légalement.
- **Signalez à la direction par écrit immédiatement.** Courrier ou mail, avec accusé de réception demandé.
- **Saisissez l'ARS en parallèle** si la situation est grave ou si vous ne faites pas confiance à l'établissement pour gérer la situation en interne.
- **En cas de maltraitance physique avérée** — dépôt de plainte auprès du Procureur de la République. Vous pouvez aussi appeler le 3977 — numéro national de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Ce que vous ne devez pas faire seul

Ne confrontez pas seul un soignant que vous soupçonnez de maltraitance. Ne retirez pas votre proche de l'établissement dans la précipitation sans préparer une solution alternative. Ne diffusez pas d'informations ou de vidéos sur les réseaux sociaux avant d'avoir épuisé les voies officielles — cela peut compliquer les procédures légales.

Signaler, c'est protéger. Pas seulement votre proche — tous les résidents de l'établissement.

5. Préserver le lien malgré le conflit

C'est le paradoxe le plus difficile de ce guide. Vous êtes en conflit avec l'établissement — et votre proche vit toujours là. Ce que vous faites a un impact direct sur son quotidien et sur la manière dont l'équipe le perçoit.

Séparer le conflit institutionnel de la relation humaine

Votre conflit est avec l'institution ou avec une décision — pas forcément avec chaque soignant individuellement. Continuez à saluer, à remercier, à traiter avec respect les personnes qui prennent soin de votre proche. Un aide-soignante qui sait que vous la respectez ira plus loin pour votre proche — même si vous êtes en conflit avec la direction.

Ne pas impliquer votre proche dans le conflit

Évitez de lui parler de vos démarches, de vos plaintes, de vos tensions avec l'équipe. Il ne peut rien y faire — et cela l'angoisse. Continuez à lui offrir des visites calmes, présentes, centrées sur lui. C'est la meilleure protection que vous puissiez lui offrir pendant cette période.

Penser à la sortie

Si le conflit est profond et la confiance irrémédiablement brisée — pensez à un changement d'établissement. Ce n'est pas une défaite. C'est une décision de protection. Le Guide G vous donnera tous les éléments pour l'envisager sereinement.

*Vous pouvez défendre les droits de votre proche avec fermeté —
et continuer à être humain avec ceux qui le soignent. Les deux ne
s'excluent pas.*

6. Modèles de courriers

À adapter à votre situation. Toujours envoyer en recommandé avec accusé de réception pour les courriers importants. Garder une copie datée de tout ce que vous envoyez.

Signalement d'un incident — à la direction

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous contacter au sujet de la situation de mon/ma [lien], M./Mme [nom], résident(e) dans votre établissement (chambre [numéro]).

Le [date], j'ai constaté [description factuelle et précise]. J'ai signalé cette situation à [nom ou poste de la personne contactée] le [date], sans obtenir de réponse satisfaisante à ce jour.

Je vous demande de bien vouloir [demande précise] et de me confirmer par écrit les mesures prises dans un délai de [X] jours. Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse mes cordiales salutations.

Signalement à l'ARS

Madame, Monsieur,

Je me permets de saisir votre agence concernant la situation de mon/ma [lien], M./Mme [nom], résident(e) à l'EHPAD [nom de l'établissement], [adresse].

J'ai constaté les faits suivants [description factuelle]. J'ai effectué les démarches suivantes auprès de l'établissement [liste des démarches avec dates] sans obtenir de réponse ou de réponse satisfaisante.

Je sollicite votre intervention pour [demande précise]. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adresse mes cordiales salutations.

Un courrier factuel, daté, avec une demande claire — c'est le document le plus puissant que vous puissiez produire.

Agir, c'est protéger.

Ne pas agir, c'est laisser la situation s'installer.

—

Ce guide fait partie de la série pratique EHPAD. Les autres guides de la série :

- **Guide A — Qui est qui :** rôles, responsabilités, bons interlocuteurs.
- **Guide B — Parler à l'équipe :** quand, comment, à qui, par écrit.
- **Guide C — Les réunions :** CVS, synthèses, projet de vie.
- **Guide D — Vos droits :** accès dossier, réclamation, loi.
- **Guide E — Le quotidien :** soins, repas, nuit, sorties, argent.
- **Guide G — Le changement d'EHPAD :** quand et comment partir ailleurs.

—

Et si vous traversez une situation difficile et avez besoin d'aide pour structurer votre démarche, rédiger un courrier ou être accompagné — je suis là.

[Votre lien de contact / site]

— *Culture du soin*